共同生活论

社会再生产、日常权力与人的自由发展

二〇二六年十月

献给那些照料他人、依赖他人，也仍想成为自己的人。

内容提要

国家民主和经济民主仍不足以保证人在日常生活中自由。一个人可以拥有选票、工作权和社会保障，却仍可能在家庭、学校、医院、照护机构、媒体、宗教社团、社区和数字平台中被他人定义、记录、代理和排斥。父母、教师、医生、照护者、专业机构、平台和熟人共同体通常不是国家机关，也不一定以利润为目的，但它们能够决定谁被视为正常，谁有资格发言，谁可以接触信息，谁的意愿被当作有效，以及谁必须承担维持共同生活的时间、身体和情感成本。

本文提出“共同生活宪制”的初步理论。它把社会再生产理解为生命、能力、信任和代际延续被持续维持的过程，把日常权力理解为通过分类、记录、许可、评价、代理决定和照护依赖运作的权力。它不把家庭视为天然和谐的私域，也不把学校、医院和公益组织视为天然代表受助者；同时，它拒绝把亲密、信仰、友谊、艺术和人生理想改造成行政机关可以统一规定的对象。

本书不可被《国家民主论》和《民主协作经济论》替代，因为它处理的是一个不同的制度困难：在生活世界里，退出经常不可得、代价极高，或者退出本身就会制造伤害。婴幼儿不能退出父母，重症患者不能简单更换照护关系，被监护者可能没有独立行动条件，遭受家庭暴力者即使法律上能够离开，也可能同时失去住所、收入、证件、子女联系和社会支持。选举、更换雇主、市场竞争和破产退出都不能直接解决这种依赖中的支配。

共同生活宪制的目的，不是消灭依赖，而是使依赖不再等于服从。本文确立九项相互关联的条件：身体和人格安全，平等法律地位，照护与被照护的权利，个人时间与独处空间，信息知情和记录更正，随能力发展的发声与决定权，支持性决策优先，真实退出及服务连续性，以及低成本、及时、可执行的救济。人的自由发展不是国家给出一张正确生活清单，而是每个人拥有形成、尝试、修改和放弃生活计划的实际能力。

本文建立三层制度结构。第一层是不可交易的个人地位和能力底线，使基本照护、居所、教育、医疗、身份文件、信息和法律援助不依附于单一家长、配偶、监护人、学校、社团或平台。第二层是家庭、学校、医院、社团、社区和平台的最低内部宪制，明确说明、记录、参与、利益回避、申诉和责任。第三层是默认休眠、

按风险触发的外部救济回路，它依照退出难度和伤害可逆性采取支持、协商、临时保护、独立复核和司法强制，而不是对全部生活实施持续监控。

本文使用“规训盈余”这一综合性工作概念，指保护措施中超出防止具体伤害所必需的分类、监控、强制和档案留存；它综合了规训分析、比例原则和最小限制替代，而不主张已经发现一个未经前人讨论的全新权力类型。制度既要追究明知危险而不介入，也要追究依据不足、措施过重、记录永久化和错误拆散关系。过度介入不能因为动机是保护就免于赔偿，干预不足也不能以尊重私域为借口。每项措施都必须说明触发事实、权限、期限、替代方案、数据范围、复审节点和退出条件。

贯穿全书的“青禾家庭”案例使制度真实失败一次。学校的风险标签、平台的情绪识别、基层儿童保护的免责激励和医疗档案相互印证，把一个照护资源不足的家庭快速分类为失职家庭，导致十三岁儿童被临时带离。低门槛的分类证据触发了高不可逆性的处置，亲子信任、学业和照护链受到实际损害。案例用时间、服务、现金、档案、决定权和损失六条流向检验：谁节省了成本，谁取得了免责，谁承担无偿劳动，谁能纠正记录，谁为错误干预和未提供支持负责。

本文不声称所提出的机构数量、复审期限、风险阈值和服务额度已经最优，也不声称外部介入一定优于家庭和社区自治。它能够提出规范底线、权限结构和失败标准，却仍须以照护时间调查、分类误差、申诉成本、强制措施、长期关系修复和分群能力结果接受比较检验。若一种保护机制持续制造更多不可逆伤害、压制内部弱者的声音或把多样生活变成统一人格工程，它就必须被修订或退出。

关键词：共同生活；社会再生产；日常权力；照护；真实退出；支持性决策；儿童权利；分类与记录；规训盈余；低成本救济

目录

内容提要 1

序言：权利进入生活世界 7

第一章 共同生活的现实主义起点 8

一 必须避免的七个跳跃 8

二 独立对象：退出失灵条件下的支配 9

三 什么进入本书，什么不进入 9

四 贯穿案例：青禾家庭 10

第二章 共同生活的目的与三层结构 11

一 相互依赖中的自由 11

二 第一层：个人地位与能力底线 11

三 第二层：生活机构的最低内部宪制 11

四 第三层：默认休眠的外部纠偏 12

五 九项共同生活权利 12

第三章 社会再生产、照护与家庭权力 13

一 使隐形劳动可见 13

二 照护是双向权利，不是单向牺牲 13

三 照护时间、现金和服务怎样流动 14

四 家庭与亲密关系的反强迫底线 14

五 亲密生活不接受统一模板 14

第四章 儿童、教育与知识权威 15

一 儿童是成长中的主体 15

二 学校不能用秩序代替教育 15

三 分类与档案是权力 15

四 知识权威与反常报告 16

五 教育的目的不是生产统一人格 16

第五章 医疗、残障、精神健康与代理决定 17

一 能力推定与支持性决策 17
二 代理决定的顺序与边界 17
三 知情同意不是签字仪式 17
四 强制医疗与最小限制 18
五 残障不是个人缺陷的总称 18
第六章 媒体、平台、社团与社区 19
一 注意力、可见性与公共承认 19
二 数字画像与跨域数据 19
三 宗教与社团自治的边界 19
四 社区自治与内部少数 20
五 公共空间与不被占有的生活 20
第七章 轻触双回路、最小介入与低成本救济 21
一 第一回路：支持—表达—协商 21
二 第二回路：异议—保护—复审—修正 21
三 最小介入阶梯 22
四 规训盈余与对称问责 22
五 谁作最终决定 23
六 低成本不是低质量 23
第八章 评价、系统性改善与可修订性 24
一 三层共同生活体检 24
二 直接影响、反馈与窗外损失 24
三 系统性卡尔多—希克斯改善的限制 24
四 真实匮乏与照护分配 25
五 试点、比较与回滚 25
第九章 青禾家庭：一次过度保护的失败 26
一 T−3至T−1：不可见的照护缺口 26
二 T0：标签怎样形成自我印证 26
三 T1：低门槛证据触发高不可逆处置 27

四 失败后的六条流向 28
五 T2：独立复审与记录拆分 28
六 T3：资源怎样实际到位 29
七 过度介入怎样承担责任 30
八 压力测试：当服务仍然不够 30
九 三种替代方案与有限结论 31
第十章 转型、接口与自我限制 32
一 第一阶段：先建立可诉底线 32
二 第二阶段：机构内部宪制与支持能力 32
三 第三阶段：跨机构救济而非统一控制 32
四 与前两部的接口 32
五 最强反方与回答 33
六 理论的地位 33
结语：使依赖不再等于服从 35
附录一 《共同生活论》规范条文草案 36
第一条 制度目的 36
第二条 生活多元与内容中立 36
第三条 共同生活基本权利 36
第四条 照护双重权利 36
第五条 真实退出 36
第六条 儿童与演进中的自主 37
第七条 能力推定与支持性决策 37
第八条 分类、记录与数据 37
第九条 生活机构内部宪制 37
第十条 轻触双回路 38
第十一条 最小介入与不可逆处置 38
第十二条 规训盈余与对称问责 38
第十三条 宗教、社团和社区自治 38

第十四条 医疗、监护与强制 39
第十五条 真实匮乏与未履行义务 39
第十六条 试点、比较与回滚 39
第十七条 合法执行依赖 39
第十八条 救济机构内部宪政 39
第十九条 理论的可修订性 40
附录二 青禾家庭事实表与决策节点 41
一 事实边界 41
二 六张流向表 41
三 基准决策链 42
四 不可逆处置的失败节点 42
五 跨章索引 42
六 同口径反事实表 42
附录三 设计参数、证据边界与未决问题 43
附录四 文献对话索引 45

序言：权利进入生活世界

人在成为选民和劳动者以前，先是一个被养育、被命名、被教育、被照护的人。我们学习怎样表达需要，怎样理解自己，怎样判断何为正常，也学习什么时候应当服从。这个过程并不发生在宪法法庭或企业董事会，而发生在卧室、饭桌、教室、诊室、宗教活动、社区群聊和手机屏幕上。

这些场所需要信任、专业和持续关系，不可能把每一次拥抱、批评、诊断、劝告和照料都变成表决或诉讼。共同生活若完全失去非正式性，人们会在规则中窒息；但若一切都被称为私事，最依赖他人的人也最难反对伤害。制度难题不是让国家进入或退出生活，而是确定何时保持轻触，何时必须提供支持，何时可以临时介入，何时必须由独立机构阻止不可逆伤害。

本书不以孤立个人为出发点。依赖不是儿童、病患、残障者和老人的例外状态，而是贯穿人生的共同条件。一个看似独立的成年人也依赖食物、教育、医疗、情感支持、公共空间和他人的照护劳动。自由不能意味着无人需要别人，而应意味着人在需要别人时仍被当作具有意愿、权利和改变能力的主体。

共同生活也不能由善意证明正当。父母可能以爱为名控制，医生可能以专业为名替代患者，学校可能以秩序为名固化标签，社团可能以传统为名阻止退出，平台可能以安全为名扩大监控，国家可能以保护为名拆散关系。动机、身份和使命不能替代权限、证据和救济。

因此，本书所说的宪制不是给生活规定内容，而是限制任何主体把自己的内容强加给他人。它要求基本权利进入家庭和机构的接口，又要求外部权力证明每次介入的必要性与比例性。共同生活的制度目标，是让人能够依赖而不被占有，能够属于共同体而不被封闭，能够接受照护而不失去主体地位，能够离开一种关系而不坠入生存断裂。

第一章 共同生活的现实主义起点

一 必须避免的七个跳跃

第一个跳跃，是从私人领域推到自由领域。家庭、友谊、宗教和社区能够给人爱、意义与归属，也能形成经济控制、身份扣押、沉默压力和暴力。国家退出不等于支配消失；有时只是让内部最弱者失去外部救济。

第二个跳跃，是从照护推到无私。照护需要时间、技能、身体和情感劳动。若社会把它视为家庭成员、尤其是女性天然应尽的义务，受照护者会依赖一个被耗尽的人，照护者也会因爱和责任难以说不。没有替代服务的道德赞美，只是把公共成本隐藏进家庭。

第三个跳跃，是从保护目的推到措施有益。错误的危险标签、永久档案、强制带离、隔离、强制治疗和过度监控都可能以保护为名。制度必须同时记录没有介入造成的伤害和过度介入造成的伤害，不能只奖励“采取了行动”。

第四个跳跃，是从法律允许离开推到真实退出。一个人若离开配偶就失去住所，离开宗教共同体就失去收入与家人，离开学校就失去教育连续性，离开平台就失去全部社交和作品，形式退出仍可能是强迫选择。真实退出要求安全、时间、信息、替代服务、身份与记录可携，以及不过度报复。

第五个跳跃，是从专业判断推到事实真理。教师、医生、社工和算法掌握专业知识，却也会受时间不足、分类偏差、组织免责、指标和既有范式影响。专业意见应得到尊重，但必须说明证据、适用范围、不确定性和替代方案，并允许第二意见和异常报告。

第六个跳跃，是从参与推到有声音。儿童出席会议、患者签署表格、家庭成员被询问、社区举行座谈，都不表示其意见改变了决定。发声权必须连接记录、回应、复议和对最终决定的影响，否则只是仪式。

第七个跳跃，是从数据整合推到照护协调。跨部门数据可以减少重复举证，也可以让一个错误标签从学校流向医院、福利、平台和儿童保护机构，形成自我印证。信息共享必须从目的限制、最小必要、主体知情、更正、期限和访问日志开始，而不是从建设统一数据库开始。

二 独立对象：退出失灵条件下的支配

《国家民主论》主要处理公共权力怎样授权、问责和更替，《民主协作经济论》主要处理生产、投资、所有、劳动与保障。共同生活论处理二者的上游：人怎样获得使用权利、理解信息、表达异议和形成生活计划的能力。

本书依退出条件把关系分成三类。第一类是通常可以退出的关系，例如多数自愿社团、媒体订阅和部分数字服务；制度重点是信息、可携带性、竞争和反报复。第二类是高代价退出关系，例如婚姻、学校、长期照护、宗教共同体和主要平台；制度须提供过渡住所、收入、服务连续性、记录转移和外部申诉。第三类是暂时不可退出或退出本身会造成严重伤害的关系，例如婴幼儿与主要照护者、急重症患者与医疗系统、部分被监护者与代理人。此时不能把“你可以离开”当作救济，必须建立独立声音、支持性决策、替代照护和高门槛的外部复核。

退出分类不是给人贴永久标签。同一个人会随年龄、健康、资源和支持变化在不同关系中移动；制度应优先增加其选择能力，而不是用“无能力”证明长期替代决定。

三 什么进入本书，什么不进入

本书处理家庭、照护、儿童、教育、医疗、残障、监护、媒体、科学、宗教、社团、社区和数字平台中的内部权力，以及基层行政、警察和司法进入这些领域的生活接口。它关注盘查、带离、记录、风险分类、强制医疗、代理决定、临时保护和日常救济。

军队忠诚、情报机关、国家安全、完整刑事司法、量刑、监禁体系和强制机关内部命令链，属于《法治与强制权》。宏观财政、公共金融、企业治理、工作场所民主和社会投资，属于《民主协作经济论》。本书会说明照护服务和退出保障需要资源，却不重写其融资体系。

本书也不回答何种家庭最美满、何种信仰最真实、何种艺术最有价值、何种亲密关系或人生才正确。制度可以保护安全、时间、空间、隐私、结社、表达和退出，不能代替个人与共同体生产意义。

四 贯穿案例：青禾家庭

青禾市十三岁的林和与母亲林芸、外祖母赵琴共同居住。赵琴患有早期认知障碍，林芸在餐饮配送平台工作，家庭照护主要由林芸承担；在林芸晚班时，林和也会照看外祖母。林和在嘈杂环境中容易失控，多次缺课，尚未完成神经发育评估。

学校风险系统根据缺勤、课堂行为和平台公开内容把林和标记为“高风险学生”。社区社工看到标签后上门，诊所建议精神评估，平台又把林和的求助内容识别为自伤风险。各机构为了避免被追究“没有预警”，不断复制标签，却没有机构负责核实照护时间、提供喘息服务或听取林和的完整陈述。

后来，一次家庭争吵被邻居报警。儿童保护机构依据学校、平台和社区记录启动紧急评估，提出带离二十一日；法定独立裁决者实际只授权七十二小时，林和却被留置到第七日。带离最初处理了一项尚不能排除的当晚危险，超期留置则造成学业中断、外祖母照护断裂和亲子信任损害。第九章将分别检验：谁提出、谁授权、谁执行，拟定期限、合法期限和实际期限为何不同，谁为超期和未提供支持负责，家庭需要多少照护时间和现金支持，档案如何更正，关系损失能否修复。

第二章 共同生活的目的与三层结构

一 相互依赖中的自由

自由不是不受任何人影响，而是不必屈从于他人不可解释、不可申诉、不可替代的意志。依赖关系中的自由至少要求三件事：当事人的意愿被认真辨认；提供照护的人不被迫无限牺牲；外部机构只能在明确条件下介入并承担错误责任。

人的自由发展不是把每个人训练成同一种理性、自足的人。它包括依赖、休息、游戏、学习、创作、亲密、信仰、独处、结社和改变方向的能力。制度只保证这些可能性不被暴力、贫困、垄断和标签任意封闭，不决定个人应选择哪一种。

二 第一层：个人地位与能力底线

任何人无论年龄、健康、残障、家庭身份和表达方式，都拥有身体完整、免受暴力和羞辱、法律人格、适当信息、隐私、通信、表达偏好和获得外部帮助的基本地位。儿童与需要支持者的决定权可以随能力与事项风险调整，但其人格地位不能暂停。

真实能力要求最低照护、居所、教育、医疗、无障碍、身份文件、通信、交通、数字接入、独立咨询和法律援助。一个人离开家庭、学校、宗教或平台后若立即失去这些条件，退出就不是真实选择。普遍服务由前两部所规定的财政和经济宪制承担，本书规定其在关系退出和机构转换中的连续性。

三 第二层：生活机构的最低内部宪制

家庭不能被改造成行政机关，但涉及财产控制、医疗同意、教育中断、监护、身体限制和长期数据记录时，必须适用明确权利。学校、医院、照护机构、宗教组织、社团、公共媒体和大型平台则应具有公开规则、责任人、记录访问、更正、利益回避、异议和外部申诉。

权力强度应与影响强度匹配。普通生活安排尽量由关系内部协商；可能造成长期学业、身体、身份、居所、财产和声誉损失的决定，需要更强说明和复核；不可逆处置必须具有最高证据门槛、独立授权和自动复审。

四 第三层：默认休眠的外部纠偏

外部救济不应持续观察全部家庭和共同体。它在四种情况下被触发：存在具体暴力或迫近的严重伤害；当事人无法退出且没有独立声音；高影响分类或代理决定缺少说明和复核；关系内部的申诉者遭到报复或被切断基本服务。

外部机构首先提供信息、翻译、无障碍、喘息照护、临时住所、独立代理和调解。只有支持不足以防止伤害时，才进入限时保护、暂停决定或司法措施。所有外部措施都须留下权限、事实、期限、替代方案和复审记录。

五 九项共同生活权利

第一，免受暴力、胁迫、侮辱和身体控制。第二，保持法律人格和随能力发展的决定地位。第三，得到必要照护，也有权拒绝特定照护方式。第四，照护者拥有休息、收入连续、健康保护和退出无限义务的权利。第五，每个人拥有不被组织完全占有的时间、空间和通信。第六，知悉关于自己的重要记录、来源、用途和访问者，并要求更正、附加异议和到期删除。第七，在影响自己的程序中表达意见、得到回应和独立支持。第八，离开关系或组织时获得安全、住所、身份、教育医疗和数据连续性。第九，以不依赖高额诉讼的方式获得临时保护、复审和赔偿。

第三章 社会再生产、照护与家庭权力

一 使隐形劳动可见

社会再生产包括生育、养育、家务、照护、康复、情绪支持、教育陪伴、关系维护以及取得服务所需的预约、填表、排队和协调。它既发生在家庭，也发生在公共服务、社区、市场和平台。社会依赖这些劳动，却经常只计算正式就业和购买服务。

制度应进行匿名化的时间使用调查和照护缺口统计，并按性别、年龄、收入、残障、家庭结构和地区分组公开。统计不能成为监控具体家庭的工具；其目的在于识别谁的时间被系统性占用、哪些服务缺失以及公共预算把成本转嫁给了谁。

二 照护是双向权利，不是单向牺牲

被照护者有权获得连续、尊重偏好和文化差异的支持，照护者也有权休息、接受培训、保持收入与社会联系，并拒绝超出能力的任务。任何一方都不能以自己的脆弱迫使另一方无限牺牲；公共系统有责任提供替代照护、喘息服务和危机接替。

照护评估应同时形成两份计划：被照护者的支持计划，以及主要照护者的承载与退出计划。前者记录偏好、功能、风险、沟通方式和替代选择；后者记录时间负担、健康、就业、休息、可替代人员和紧急联系。两份计划不得互相吞并。主要照护者明确提出已经无法继续承担高强度照护时，公共责任机构须在二十四小时内提出临时接替方案；未能接替的小时记为公共未履行，不得据此认定照护者遗弃，也不得把风险全部转嫁给被照护者。

照护者与被照护者在居住、服务方式、通信、财产或风险承受上发生重大利益冲突时，不由其中一方、其代理人或服务提供者单方决定。应由独立于双方和服务提供者的第三方，在分别听取双方意见、提供沟通支持并比较较小限制方案后作出限时决定；无法形成一致时，决定书须记录未被采纳的意见、复审时间和退出条件。

三 照护时间、现金和服务怎样流动

照护支持可以由普遍服务、个人照护预算、带薪照护假、照护者津贴、专业服务和社区互助共同构成。现金不能代替可得服务，服务也不能以家庭仍有一名成员为由拒绝。支付给照护者的补贴是对时间和机会成本的部分承认，不购买其全天候服从。

高强度照护家庭应获得一个可核对的照护账户：列明公共服务小时、家庭自愿承担小时、专业人员小时、等待和未满足小时，以及相关现金和交通支持。该账户不能成为考核家庭道德的排行榜，只用于发现缺口、协调资源和触发替代服务。

四 家庭与亲密关系的反强迫底线

家庭形式可以多样，但暴力、性强迫、证件扣押、通信隔离、经济控制、教育剥夺和以公开羞辱迫使服从，不能以家庭自治为由豁免。受害者应能秘密接触帮助，获得紧急住所、基本收入、医疗、证件补发、儿童联系安排和法律援助。

外部机构不得把一切冲突都解释为暴力，也不得强迫受害者立即永久离开。临时保护、风险评估、关系修复和长期退出是不同选项。当事人有权在不危及儿童和他人的前提下选择路径；专业人员必须说明保密边界和强制报告条件。

五 亲密生活不接受统一模板

共同生活宪制不规定家庭人数、性别分工、婚姻形式、亲密强度和情感表达。它只检验成员是否有真实同意、是否能保留基本资源和外部联系、是否能反对伤害、是否有可行退出。国家无权因生活方式不合主流而推定风险，机构也不能把贫困、残障、单亲或文化差异自动等同于不合格家庭。

第四章 儿童、教育与知识权威

一 儿童是成长中的主体

儿童需要保护，但保护不能把儿童变成家庭和机构的财产。儿童的表达和决定能力随年龄、经验、支持和事项而变化，不应由单一年龄线一次性打开或关闭。低风险日常选择主要由儿童决定；教育、医疗、居住和身份等高影响事项，儿童应获得适龄信息、表达机会和独立支持；不可逆处置的门槛最高。

法定代理人应推定为儿童利益行动，但不能垄断儿童声音。家庭利益冲突、儿童明确提出异议、代理人可能施害或决定具有重大不可逆性时，应指定独立儿童代理人。代理人不是替儿童重新作一次家长决定，而是帮助儿童理解、表达、保留异议并启动复审。涉及带离、长期转学、重大医疗、监护和其他高影响决定时，儿童应在可信支持者陪同下直接向决定者陈述；决定书须逐项回应其意见。独立代理人由与调查和服务机构分离的公共法律援助名册轮转产生，一案一任，不得与涉案机构具有人员、预算或承包关系。

二 学校不能用秩序代替教育

学校拥有维持教学和保护安全的责任，却不能通过不透明分班、处分、心理标签、推荐信和算法画像把学生锁定在单一路径。高影响教育决定须告知依据、证据、不确定性和替代方案，学生与家长能够查阅记录、提出异议并获得外部复核。

处分应优先修复伤害、恢复学习和重建关系。停学、转校和隔离不得成为方便学校移除困难学生的工具。若学生因照护、残障、疾病、迁移或家庭危机缺勤，学校首先负合理适配和连续受教义务，而不是立即归类为懒惰、失管或危险。

三 分类与档案是权力

学校、医院、社工、科研和平台形成的标签会跨越原始场景影响升学、就业、福利、保险和社会声誉。任何高影响分类都应具有明确目的、证据来源、有效期、访问范围和复核途径。推断与事实必须分开，异议不得从正式档案中消失。

记录主体有权知道谁在何时访问或转移记录，有权更正事实错误、附加自己的陈述，并在目的消失后要求删除或限制使用。源机构须向全部已知下游接收者发送

更正或删除通知；下游机构应在四十八小时内停止用争议标签作出新决定，并在七日内回执更正、删除或依法保留的具体依据。义务覆盖副本、缓存和由该标签生成的个人画像；已经进入聚合模型训练的数据，不作技术上不真实的“从模型中逐字删除”承诺，但须停止用于新的个体画像，并在影响具有实质性时重新训练、校准或停用模型。涉及公共安全和法定义务的保留例外必须具体列举、限期复审，不能以“可能有用”为由永久保存。

四 知识权威与反常报告

教师、医生、心理师和科学共同体需要专业自治，民主不能用多数表决决定事实。但专业共同体必须公开方法、利益冲突、证据限制和不确定性，并保护少数报告与可复核的反常。这里的“反常报告”只是一个工作性类比：学校、诊所和家庭不是科学实验室，却都需要让不符合主流分类的事实进入复核。一个分类体系若持续出现分群误差，不能把所有异常解释为个体不配合。

家长、学生和患者的经验不自动推翻专业证据，却能够指出模型遗漏、执行伤害和生活情境。制度要使两类知识相遇，而不是让专业语言取得不可申诉的统治资格。

五 教育的目的不是生产统一人格

教育应发展理解、判断、合作、批评和实践能力，使人能够进入共同世界，也能够质疑其规则。国家可以确定基本读写、科学、历史、公民能力和反歧视底线，却不应把忠诚于某一政党、宗教、职业或生活方式作为完整人格标准。

第五章 医疗、残障、精神健康与代理决定

一 能力推定与支持性决策

表达方式、诊断、年龄和需要帮助不等于没有决定能力。制度首先推定当事人能够参与，并提供易读信息、翻译、沟通辅助、安静环境、充分时间、可信支持者和分步选择。只有在支持后仍无法就特定事项形成或表达决定，才讨论替代决策。

能力判断必须限定于具体事项和具体时间。一个人可能不能处理复杂财产，却能决定日常生活和医疗偏好；也可能在急性期需要代理、恢复后重新取得全部决定权。一次认定不得产生终身失权。

二 代理决定的顺序与边界

替代决策首先依据当事人的预立指示、长期价值和可辨认意愿；只有无法确定时，才采用最佳利益标准。代理人须说明自己如何辨认意愿、存在哪些利益冲突、比较了哪些替代方案。重大财产、居住、绝育、长期隔离、精神外科和其他不可逆决定不得由单一代理人自行作出。

当代理人和专业人员意见冲突时，法院不应直接成为医疗管理者。争议期间以维持生命、维持现状和最小限制为默认，不得实施可以安全等待的不可逆措施。独立临床复核先判断事实、风险和替代方案，共同生活救济机构再审查程序、支持是否充分及利益冲突；仍涉及基本权利、强制、重大不可逆性和权限争议时，才由法院裁决。决定书须指定医疗机构中的具名执行责任人和执行期限。

三 知情同意不是签字仪式

知情同意要求当事人理解目的、主要风险、不接受的后果和现实替代。低风险、可逆措施可以简化程序，高风险和不可逆措施必须加厚说明、冷静期和第二意见。机构不能用冗长表格把风险转嫁给患者，也不能以患者签字掩盖信息不对称。

急迫危险下可以采取维持生命和防止严重即时伤害的必要措施，但权限只持续到恢复沟通或独立复核所需的最短时间。紧急不能自动延长为常态。

四 强制医疗与最小限制

强制医疗必须以具体、迫近、严重伤害风险为条件，并证明自愿支持、社区服务和较小限制方案不足。作出强制决定的机构不得同时独占治疗、关押、记录和复审；独立授权、及时律师或代理支持、自动复审和日落不可缺少。

未发生伤害不证明强制合理，发生危险也不证明任何强制都合理。审查应比较当时可得证据与替代方案，而不是只用事后结果奖惩。错误强制造成的身体、名誉、工作和关系损失，应有更正、赔偿和持续支持。

五 残障不是个人缺陷的总称

人的困难来自身体、认知与环境相互作用。无障碍、沟通支持、助理、辅助技术和合理适配可以改变能力边界。制度不能一边拒绝支持，一边用缺少支持后的表现证明一个人无能力。

残障者组织和有经验者应参与规则制定，但代表不能代替每个个体同意。公共系统既要防止机构化隔离，也要承认部分人确实需要高强度、长期、稳定的支持；社区照护不能成为把全部责任退回家庭的口号。

第六章 媒体、平台、社团与社区

一 注意力、可见性与公共承认

媒体和平台决定哪些声音被看见、哪些行为被放大、哪些身份被污名化。表达自由不保证每个人获得同等传播，但大型平台和公共媒体不能以秘密规则系统性压低某类合法表达、放大骚扰或让纠错永远追不上污名。

公共媒体应区分事实、意见和推断，提供可见更正和答辩。平台应公开主要推荐与限制逻辑、利益关系和申诉路径，对涉及未成年人、自伤、暴力和重大名誉损害的内容提供快速人工复核。人工复核不是把算法黑箱换成人员黑箱，同样需要理由和记录。

二 数字画像与跨域数据

数据主体有权知道高影响画像使用了哪些来源、推断了什么、影响哪些决定。平台、学校、医院和政府不得仅因技术上能够连接就共享数据。共享须具有明确法律或同意基础、同一目的、最小字段、期限、访问控制和独立审计。

自动系统只能生成提示，不能单独作出儿童带离、强制治疗、福利取消、重大处分和监护资格等决定。若机构依赖模型，它必须保留能够反驳模型的人类责任人，并公开模型在相关人群中的误报、漏报和不确定性。

三 宗教与社团自治的边界

宗教和社团有权解释教义、选择仪式、组织内部活动并保持不同于主流的生活。但自治不包括暴力、强迫婚育、扣押证件、限制基本教育医疗、侵占财产、阻止求助和惩罚退出者。公共资金和法定服务不得以宗教参与为条件。

真实退出需要物质与关系过渡。退出者提出外部求助后，不以原共同体同意或已经发生刑事暴力为前提，即可申请临时住所、基本收入、证件与通信保护、教育与医疗连续、隐私保护、心理支持和新社群接入；危及居住和人身安全者应在二十四小时内获得过桥安排。服务由普遍服务和临时保护预算先行承担，再依法向侵权者追偿。国家不判断信仰真伪，只保证人能够进入、保留异议和离开。

四 社区自治与内部少数

社区最接近生活情境，能够发现正式机构看不见的需要，也可能由熟人、长老、物业、慈善组织和活跃居民控制。社区治理应公开成员边界、公共资金、规则修改、利益冲突和申诉；重大资源分配不得只由参与会议最频繁者决定。

社区调解适合处理可修复的邻里和关系冲突，不适合替代家暴保护、儿童安全、严重歧视和基本权利救济。当内部权威本身可能施害时，当事人须能越级接触外部机构，且不经社区同意。

五 公共空间与不被占有的生活

人的自由发展需要不以消费、工作、治疗、学习成绩和身份表演为条件的时间与空间。公园、图书馆、文化设施、运动场、数字公共空间和安静空间，是共同生活基础设施。它们应无障碍、可负担并允许多样使用，而不是只服务高消费活动或被持续商业监控。

第七章 轻触双回路、最小介入与低成本救济

一 第一回路：支持—表达—协商

第一回路发生在关系和机构内部。其默认工具不是监控和惩罚，而是信息、沟通支持、合理适配、喘息照护、替代安排、异议记录和关系修复。家庭、学校、医院、社团和平台必须指定能够回应问题的人，但不能要求当事人先向可能施害者重复申诉。

内部协商只有在力量差距可被支持、没有迫近危险、拒绝参与不会招致报复时才适用。调解不是基本权利案件的必经门槛，也不能用“家庭和谐”迫使受害者与施害者面对面。

二 第二回路：异议—保护—复审—修正

第二回路由当事人、可信支持者、儿童代理人、专业人员或法定报告触发。独立的共同生活救济中心只负责统一入口、保密咨询、个案分流、最长七十二小时的临时保护或记录冻结，以及督促其他主体执行；独立代理由公共法律援助名册轮转产生，临床第二意见由分离的专业网络承担，三级措施超过七十二小时和所有第四级措施必须移交法定独立授权主体。中心不得主动生成风险名单、集中持有跨案原始生活数据库，也不同时经营学校、医院和照护机构，不能从增加强制处置中获得预算奖励。

当异议涉及具体暴力、严重不可逆伤害或机构拒绝执行复审时，案件进入法院或具有法定独立性的专门裁决。所有裁决最终依赖合法强制执行；本书不假定命令会自动落实，并把强制机关拒绝执行或扩大执行的问题移交《法治与强制权》。

三 最小介入阶梯

第一级是信息、无障碍和自愿支持。第二级是合理适配、喘息服务、独立代理、调解和替代安排。第三级是限时的记录冻结、决定暂停、临时住所、接触限制和服务接替。第四级是儿童带离、长期监护、强制医疗和其他重大限制。措施越高，证据、独立授权、理由、复审频率和赔偿责任越强。任何重大限制决定书必须同时列明决定者、复审者、执行者、执行时限、拒绝或迟延执行的报告途径、退出条件和先行赔偿责任人；缺少其中一项，不得作为延长限制的依据。

若较轻措施能够防止伤害，机构不得选择较重措施；若较轻措施缺少现实资源，机构也不能把这种缺失当作重措施必要性的自然证据。未提供公共支持而制造的危机，不得全部归责家庭和个人。

四 规训盈余与对称问责

规训盈余是一个可审计的工作概念，指实际措施相对于最小充分方案多出的数据字段、共享对象、限制强度、覆盖人数和持续期限。最小充分方案须在决定作出时登记；若事后改变，只能根据当时可得证据审查，不能用结果倒推。新增数据、延长期限、扩大共享和提高限制都须重新说明理由。

问责必须对称。明知具体危险、依法应介入却消极不作为，要承担责任；依据不足、忽视较轻替代、使用过重措施或不按时退出，也要承担责任。过度介入由实施机构预先列支的问责预算先行赔偿，资金不足时由该级公共过错救济基金预付，再向故意、重大过失或违法拒不纠正的机构和责任人追偿。临时或最终决定须写明付款账户、责任主体、触发事实、到账期限和拒付后的执行途径；无争议的医疗、交通、误工和服务恢复费用应先行支付，关系、名誉和时间损失不能因难以货币化而不被确认和修复。基本救济不得等待内部追责结束。机构考核不得只统计“发现多少风险”和“采取多少措施”，还须统计误报、被推翻决定、关系损害、记录更正、超期限制和服务缺口。问责统计以机构和程序节点为主，不得另建经办人员的永久行为画像。

五 谁作最终决定

普通生活和低风险事项由本人或关系内部决定。儿童和需要支持者的高影响事项实行能力递增参与、支持性决策和独立声音。专业人员负责事实判断和方案说明，但不得独占价值选择。共同生活救济中心负责临时保护、程序、代理和记录救济；法院负责权利、权限、重大强制与不可逆处置，不替代家庭和专业机构经营日常生活。

任何机构都无权既定义风险、收集证据、提供服务、实施强制，又作最终复审。救济中心内部的临时保护与程序复审由两套人员、两条预算线和不同负责人承担，同一人员不得参与同一案件的保护决定与复审；违反者，复审应由另组人员重做。确有资源限制时可以共享后台能力，但职能、人员利益与复审权限必须分离。

救济中心自身作出的临时保护、记录冻结和代理指派，同样可以即时向中心之外的法定独立裁决者申诉；涉及人身、居住、亲子联系或持续数据限制的措施，应自动送交快速外部复核。法定期限内未完成复核的，措施原则上自动解除；若解除会造成具体、迫近的严重伤害，须由外部裁决者另行书面授权最短续期，不能由中心自行延长。

六 低成本不是低质量

救济入口应允许口头、文字、辅助沟通和可信第三人提出，不要求先准确引用法律。案件按迫近伤害、不可逆性、退出难度和力量差距分流，而不是按申请人表达能力分流。临时保护须快速，事实复核须充分，最终决定须书面说明。

恶意骚扰、重复无新事实申请和虚假举报可以受到适当限制，但不得用少数滥用证明提高所有人的门槛。匿名举报可以触发核验，不能单独成为永久档案和不可逆处置的充分依据。

第八章 评价、系统性改善与可修订性

一 三层共同生活体检

第一层是地位底线：是否免受暴力与强迫，是否保有法律人格、通信、外部求助和基本服务。第二层是过程质量：决定是否说明，记录是否可见，声音是否被回应，支持是否先于替代，措施是否限时，救济是否独立。第三层是正义画像：照护时间、等待、处分、强制、分类错误、申诉成功、退出损失和关系修复怎样在不同群体之间分布。

平均满意度和总体服务量不能掩盖内部弱者。儿童、残障者、无偿照护者、家庭暴力受害者、被监护者、精神卫生服务使用者、宗教少数内部异议者和数字平台边缘用户，应单独进入评价。

二 直接影响、反馈与窗外损失

任何制度改革都须画出直接影响、间接影响、外部性、反馈和尾部风险。加强儿童保护可能减少漏报，也可能提高过度带离；整合健康数据可能加快服务，也可能固化错误；增加照护津贴可能承认劳动，也可能加深家庭成员退出困难。

短期指标尤其容易把损失推到窗外。儿童带离当日的安全不能替代一年后的关系、学业和心理结果；强制医疗中的症状稳定不能替代身体副作用和信任；平台删除内容的速度不能替代被错误封禁者的生计与声誉。

三 系统性卡尔多—希克斯改善的限制

如果一项改革提高总体服务、而使特定群体承担集中且可补偿的损失，受益者原则上能够补偿受损者只是第一步。补偿须有资源来源、责任主体、触发条件、到账时点、申诉和未履行后果。关系、名誉和时间损失虽难以货币化，也必须被承认、修复和记录。

身体完整、人格地位、反强迫、外部求助、和平更替和不可逆伤害不是普通可交易损失。无法可靠比较收益和损失、补偿不可信或尾部风险过高时，应明确标记“尚不构成系统性改善”，只能缩小试点、增加保护或停止。

四 真实匮乏与照护分配

照护人员、床位、住房和专业支持会真实不足。匮乏不能通过降低权利标准在账面消失。机构应公开需求、可用能力、等待、未满足服务、优先规则和追加资源责任，并把未提供的服务记为未履行，而不是自动视为家庭已经承接。

紧急分配依次审查迫近严重伤害、不可逆损失、基本功能、真实退出难度、替代支持缺失和等待时长；同一层级内再以预计恢复难度排序。不得以收入、社会声望、家属表达能力和机构方便作为隐藏标准。分配者须公布规则并说明个案适用，决定者不得同时借资源不足证明更重限制当然必要。临时排序必须有期限、复审、扩容计划和对等待者的过渡支持。

五 试点、比较与回滚

独立儿童代理、生活救济中心、照护账户、分类日落和平台风险复核都是制度假说。试点须预先登记目标、替代方案、误报漏报、分群结果、预算、关系损害和停止条件。只与没有任何支持的最差方案比较，不足以证明优越。

扩围前应与至少两种替代安排同口径比较，并跟踪窗口外结果。若过度介入、数据泄露、等待和组织俘获超过阈值，应暂停新增案件、保护在途权利、修订或退出。试点对象不能因制度失败失去原有保障。

第九章 青禾家庭：一次过度保护的失败

一 T－3至T－1：不可见的照护缺口

案例中的时间与金额都是虚构的可替换参数，不是现实预测。林芸每月有一百八十小时有偿工作，另承担约九十小时外祖母照护和四十小时家务协调；林和承担约三十小时看护、取药和陪伴。社区提供每月十六小时上门服务，另有约三十小时照护无人稳定承担。

家庭每月可支配现金一万一千元，其中住房、食物、交通、医疗和教育等基线支出九千三百元。林芸若减少晚班，每月约损失一千八百元；私人替代照护每月需要两千四百元。家庭并非没有收入，而是照护服务、工作时间和现金在同一位置形成缺口。为使后文可重算，基准照护恒等式设为：外祖母每月总需求一百三十六小时＝林芸九十小时＋林和三十小时＋社区十六小时＋未满足零小时；所谓“三十小时缺口”不是需求未被完成，而是由林和承担、且在其上学与休息条件下不可持续的家庭替代小时。林和退出照护后，需新增三十小时正式服务，另加十小时预防性弹性容量。

学校只看见林和八次迟到和四次缺勤，没有看见三十小时照护。社区只看见林芸多次不在家，没有把平台排班和外祖母需要连接起来。贫困、照护不足、神经发育差异和家庭暴力风险是不同事实，却被一个“高风险家庭”标签合并。

二 T0：标签怎样形成自我印证

学校风险系统根据缺勤、课堂冲突和公开平台文字生成提示。班主任在时间压力下把提示写入学生支持记录，未区分事实、推断和待核实信息。平台自动识别林和关于“想消失”的文字，将内容降低可见并发送风险提示，却没有说明文本可能表达愤怒而非具体自伤计划。

社区社工看到学校记录和平台提示后上门。林芸因担心失去监护权拒绝交出手机和医疗记录，这又被解释为“不合作”。诊所看到社区转介后建议精神评估；新的建议反过来被学校视为原标签已经得到医疗证明。四个机构没有共享完整事实，却共享了彼此的结论。

三 T1：低门槛证据触发高不可逆处置

第零日二十时四十分，邻居报警称听到摔门、物品破裂和哭声。二十一时十分，现场人员没有发现身体伤害或武器，但分别记录到三项不能合并为标签的事实：林和当时拒绝立即回到同一房间，林芸处于明显耗竭状态，外祖母当晚有走失风险。现场人员通过易读语句询问赵琴；她表达希望留在熟悉住所、不愿林和继续承担固定照护。若无法取得其意思，记录必须说明尝试过的沟通支持和失败原因，不能因认知障碍默认她没有意见。学校、平台和社区形成的旧标签只能作为待核线索，不算三份相互独立的证据。

现场人员先询问林和指定的两名可信成年人，并核验其是否与冲突方存在共同施害、重大利益冲突或明显照护不能；二人均不能在两小时内到场。值班协调员又查询上门支持和成人临时照护，当晚没有空缺。二十一时五十分，儿童保护机构据此向法定独立值班裁决者申请带离二十一日。该机构只有申请和执行职责，无权签发命令。值班裁决者只授权一夜临时安置至次日上午十时，由不参与调查、授权和最终复审的服务提供者承担照护。次日听取林和、林芸、赵琴和现场记录后，裁决者把合法授权总期限限定为从首次带离起七十二小时，即第三日二十一时五十分，并书面要求在到期前形成返家或重新申请方案。

这一晚是真正困难的选择：危险证据不足以证明长期带离，却也不能当场排除冲突升级和照护链同时断裂。最初短期分离的依据不是贫困、旧标签或“没有服务”本身，而是当时的具体冲突、林和的即时表达、照护者暂时失去承载能力以及所有可即时到场的较轻替代均告失败。所谓“一夜临时照护”只有在当事人同意、保有通信和离开能力时才是支持；若不同意并被限制人身、通信或亲子联系，它就是事实上的第四级措施，必须取得相应独立授权，不能以服务名义降级。命令同时列明服务提供者、联系权、到期时点和错误赔偿账户。

程序仍有缺陷。紧急听取没有可信支持者在场，独立儿童代理直到第二日才接入；申请书也把未核实标签放在事实之前。更严重的是，七十二小时到期时没有新证据和新命令，安置机构却依据内部“过渡观察”记录继续留置。拟定期限是二十一日，合法授权期限是七十二小时，实际持续七日；第四日至第七日的九十六小时没有合法授权。制度失败不在于承认当晚存在不确定危险，而在于把短期例外滑成未经授权的继续控制。

四 失败后的六条流向

第一条是时间。林和停止照护外祖母，却每天花费数小时适应临时安置和参加评估；林芸减少工作处理程序；社工时间被大量用于证明原决定合理。第二条是现金。家庭损失工资和交通费，公共系统支付安置和评估，原本较低成本的喘息照护仍未到位。

第三条是信息。学校推断、平台提示、社区观察和诊所建议在档案中相互引用，原始来源和置信度逐渐消失。第四条是决定权。林和、林芸和外祖母的决定权下降，临时机构和专业人员取得控制；但没有单一机构对整个家庭照护链负责。

第五条是照护。外祖母的三十小时缺口扩大，公共系统紧急采购临时服务；林和不再承担照护，却也失去熟悉关系。第六条是损失。学校、平台和机构取得免责，关系创伤、污名、误工和学业损失主要由家庭承担。

五 T2：独立复审与记录拆分

第二日，林和通过临时安置点的外部通信渠道联系共同生活救济中心。中心指定独立儿童代理，并冻结相关标签向新机构继续扩散；它没有签发或续签带离。安置机构在第七十二小时没有执行到期解除，代理人遂把超期留置作为独立事项提交中心之外的法定复审者。

第七日，复审者把记录拆为现场事实、专业意见、算法推断、匿名报告和当事人异议五类，认定最初七十二小时具有最低限度的事实基础，但此后九十六小时既无新证据，也无有效授权。复审没有宣布家庭毫无风险，而是把风险拆开：争吵需要安全计划，照护缺口需要服务，林和的表达需要自愿评估，学校环境需要合理适配，外祖母需要支持性决策。复审命令当日解除留置并启动分阶段返家，林和在第七日二十一时五十分前回家；随后保留每日自主联系和两次独立回访，并把超期四日移入赔偿和执行责任程序。

正确程序不存在“过渡观察”这一续留通道。七十二小时届满，执行者只能解除限制；若出现新的具体事实，申请者须重新证明较轻方案不足，由未参与调查、安置和服务提供的独立裁决者具名授权下一个最短期限。第七日复审只能确认超期、命令返家和启动救济，不能倒签命令追认前九十六小时。

六 T3：资源怎样实际到位

试点参数分成实供与容量两栏。每月新增三十小时常规上门服务，替代林和原有的固定照护；另预留十小时弹性容量，应对复诊、突发加班或服务中断。未被调用的弹性容量不是已经发生的照护，不进入当月实供合计。另提供二十四小时喘息服务，它替代林芸原有九十小时中的一部分。修正后的正常月份为：总需求一百三十六小时＝林芸六十六小时＋社区原有服务十六小时＋新增常规实供三十小时＋喘息实供二十四小时＋林和固定照护零小时＋未履行零小时；备用容量十小时在等式之外单列。

备用被调用x小时时，须记录它替代了林芸、社区或其他哪一项原定劳动，例如林芸临时加班八小时，则当月等式改为林芸五十八小时＋原社区十六小时＋新增常规三十小时＋喘息二十四小时＋备用实供八小时＝一百三十六小时，而不是把需求写成一百四十四小时。六个月内每月一千二百元照护过渡补贴用于弥补林芸减班损失的一部分，并由学校提供弹性到校、安静空间和学习补回。资金分别来自普遍照护财政、危机预防预算和教育合理适配预算，不从儿童安置机构按人头获得的预算中相互挪用。

服务账每月核对：总需求一百三十六小时＝林芸实际承担小时＋林和自愿且不损害受教与休息的小时＋公共常规实供小时＋喘息和已调用备用实供小时＋未履行小时。承诺、排班容量、实际提供和未履行分别成栏，不能用尚未调用的备用容量冲抵家庭劳动。现金账分别列家庭、公共系统和机构：家庭净损失＝减工、交通、咨询和其他必要支出－过渡补贴－先行赔偿；公共支出＝上门照护＋喘息服务＋备用容量＋教育适配＋法律援助＋补贴＋赔偿＋关系修复。未履行服务和未支付现金不得相互抵销。

林和可以自愿参加神经发育评估，结果只用于支持方案，不自动进入处分和儿童保护档案。林芸接受家庭冲突支持，但不以承认失职为获得服务的条件。外祖母通过易读沟通表达希望留在熟悉住所，并确定两名替代联系者。

七 过度介入怎样承担责任

复审确认最初七十二小时临时保护在当时信息下具有可辩护性，但申请书混入旧标签且独立声音接入迟延，仍构成程序缺陷。超过七十二小时的九十六小时既无新证据也无合法命令，是独立的执行侵害；安置机构不能用内部记录代替外部授权。原“失职家庭”标签被删除，保留一份限期安全与服务计划，访问过错误标签的机构收到更正通知。

家庭获得误工、交通和必要咨询费用补偿；林和得到学业修复、心理支持和一份可附于档案的个人陈述。赔偿不能恢复全部信任，因此机构还须记录关系损失、公开匿名化复盘并修改延长带离的授权分离规则。

八 压力测试：当服务仍然不够

若全市同时出现照护人员短缺，原计划的三十小时新增常规服务和十小时备用容量合计只能配置二十四小时，二十四小时先计入常规实供，因此常规服务未履行六小时；未能建立的十小时只记为备用能力缺口，尚未发生调用时不计作十小时实际服务未履行。若某晚实际调用八小时备用而无人到场，则该八小时才进入当月未履行服务，并说明本应替代谁的劳动。城市应提供现金购买、跨区服务、临时日间照护和照护者减工收入保险的组合，并公开等待优先规则。

若危险恰在服务缺口当晚出现，现场人员必须先列出身体伤害、具体威胁、可接近的危险物、儿童即时陈述、照护者当时能力、被照护者的事项化意愿和可信成年人能否到场，不得把标签、贫困或“没有服务”本身写成危险证据。首选经冲突筛查的安全成年人、现场分离、上门支持或不参与调查的短期服务提供者；只有这些方法不能控制具体、迫近的严重伤害时，儿童保护机构才能向法定独立值班裁决者申请最短第四级措施。非自愿且限制人身、通信或联系的“一夜支持”按实际效果认定为第四级措施。命令到点自动解除，续期需要新证据和新授权。

这一规则不能消除坏条件下的两类错误。若错误地没有升级，负有现场保护职责的机构须说明其事实判断并承担漏报责任；若错误升级或到期不解除，实施机构先行赔偿，公共过错救济基金预付。公共系统未建设服务能力的责任另行记账，不能由家庭承担，也不能因事后平安而抹去当时的判断错误。

九 三种替代方案与有限结论

第一种方案是不介入，只提供一般福利，可能减少过度带离，却可能遗漏真实暴力。第二种是广泛数据整合和自动预警，可能提高发现速度，却会放大标签和免责型干预。第三种是本文提出的支持优先、独立声音、分级介入和对称问责。比较采用同一三十日窗口、同一家庭事实、同一可用服务能力和同一损失口径，分别列出家庭时间与现金、公共支出、服务实供与未履行、标签传播、决定主体、严重伤害和关系学业损失。另选取同校、课堂行为相近但没有照护负担的学生作差异比较，用于检验学校风险系统究竟在识别危险、神经差异还是家庭照护责任。

青禾案例只能说明第三种方案的权限和损失链可以被检查，不能证明它在现实中必然优于其他方案。至少须补齐三张同口径表：带离与安置、支持优先而不带离、仅一般福利；每张都报告三十日流量和一年后的关系、学业、健康、声誉与再介入结果。仍须比较误报、漏报、严重伤害、照护缺口、关系修复、财政成本、工作人员负担和最不利群体结果。透明地承认一次错误，不等于已经证明制度优越。

第十章 转型、接口与自我限制

一 第一阶段：先建立可诉底线

改革首先保证外部通信、紧急保护、身份文件、住所、基本服务连续、记录访问和独立咨询。没有这些底线，不宜先建设大型综合数据平台和复杂参与机构。最依赖他人的人必须能够在不经内部权威许可的情况下接触帮助。

二 第二阶段：机构内部宪制与支持能力

学校、医院、照护机构、宗教和社团、平台与社区逐步建立说明、异议、记录更正、利益回避和复审规则，同时扩展喘息照护、支持性决策、无障碍和独立代理。程序与服务必须同步；只有申诉而没有替代资源，会把权利变成排队。

三 第三阶段：跨机构救济而非统一控制

城市和地区可以建设共同生活救济中心、专业复核网络和匿名化统计，但不应把全部原始生活数据集中到一个常设监控系统。跨机构协调应通过最小必要数据、经授权的案例会议、访问日志和到期删除完成。救济机构也必须接受外部审计、任期限制、利益回避和司法审查。

四 与前两部的接口

《国家民主论》提供基本权利、国家能力、双回路、司法和合法强制的规范基础；本书把这些原则带入生活世界接口。《民主协作经济论》提供普遍服务、照护资源、住房、收入、工作时间和转型保障；本书规定这些资源怎样使退出和支持性决策成为真实能力。

若财政不能支付承诺，须按前两部规则公开现金、服务能力、未履行义务和损失承担。若法院和救济决定被军警、情报或行政机关系统性拒绝执行，问题进入《法治与强制权》，并可能触发对三部核心结构的重新审议。

五 最强反方与回答

第一项反方认为，制度进入家庭和亲密生活必然制造更细规训。本书的回答不是声称风险不存在，而是以默认休眠、触发条件、最小介入、档案日落、规训盈余和对称问责限制保护权力。若这些限制仍不能阻止扩张，相关机制应停止。

第二项反方认为，文化和家庭差异无法接受共同标准。本书只统一反暴力、反强迫、人格地位、外部求助和真实退出，不统一生活内容。群体自治不能成为内部弱者没有权利的许可证，多元也不能由外部多数随意取消。

第三项反方认为，低成本救济会造成申诉泛滥、专业防御和财政过载。本书要求分级入口、临时措施与最终审查分离、重复申请规则和真实资源账户，但承认机构能力必须经验校准。行政方便不能取消权利，权利也不能使资源约束消失。

第四项反方认为，照护、身份和意义不可量化，制度只能制造虚假指标。本书同意指标不能替代关系判断，因此同时保留定量分群、个人陈述、少数报告和长期随访。不可完全量化不等于可以不说明、不记录和不负责。

六 理论的地位

共同生活论不是关于善生活的终局学说，也不是把所有社会问题交给同一机构的总计划。它是一组限制权力、支持依赖、开放异议和纠正伤害的宪制原则。其制度假说必须接受替代方案、现实预算、组织能力和长期结果的检验。

依赖关系可能形成支配，并非本文首次发现。本文的主要贡献应放在制度组合与权限设计：把多源支持、独立声音、分级介入、数据纠错、到期解除、执行责任和先行赔偿连接成同一条可审查的链。它不以提出一个新名称代替与既有儿童、照护、残障和家庭正义理论的比较。

以Gheaus关于儿童免受照护垄断的论证为例，稳定的非父母照护关系和多个利益不完全捆绑的权威来源，能够在伤害发生以前增加儿童的求助入口；这比等到触发外部救济更早。本文增加的不是这一发现本身，而是当学校、医院、平台、监护人和多个照护来源共同失灵、彼此甩责或复制错误时，怎样追踪权限、纠正记录、解除限制并赔偿。前一种路径可能因资源不平等、责任碎片化和关系不稳定而失败，后一种路径可能介入过晚并形成专业垄断。两者互补，但都不能独自证明儿童已经获得自由。

若本书持续遗漏某类依赖、使内部弱者更难发声、把支持变成监控、把多样生活压成统一人格，或者其救济成本超过实际可达能力，它就应被公开修订。批评一种保护机制，不等于支持伤害；拒绝一种家庭或文化模板，也不等于拒绝共同权利。

结语：使依赖不再等于服从

共同生活无法由制度制造。信任、爱、友谊、信仰、创造和归属只能在人的行动中生长。制度能够做的，是阻止某个人或组织垄断这些关系的入口和出口，保证弱者能够说话，保证提供照护的人不会被耗尽，保证分类和保护权力接受复审。

国家民主让公共权力能够被反对，经济民主让生产和投资权力能够被约束，共同生活民主则要求人在最日常、最依赖、最难离开的关系中仍保有主体地位。它不是把会议带进每个家庭，而是让家庭和机构都不能封死外部世界；不是消灭专业，而是让专业说明边界；不是把儿童和依赖者假定为完全自足，而是使支持增加其能力，而非永久取代其意愿。

自由发展的社会，不是没有依赖、冲突和错误的社会，而是依赖可以得到支持、冲突不会自动转化为支配、错误能够在造成更大不可逆伤害前被发现和修正的社会。

附录一《共同生活论》规范条文草案

第一条 制度目的

共同生活制度应保障每个人在社会再生产、照护、教育、医疗、媒体、社团、社区和数字空间中的平等人格、真实能力和免受任意支配，使依赖不等于服从，使多种生活形式能够在基本权利边界内共存。

第二条 生活多元与内容中立

公共机构不得规定唯一正确的家庭、信仰、亲密关系、艺术和人生。生活形式的自由止于暴力、强迫、人格否定、阻断外部求助和实质剥夺退出。

第三条 共同生活基本权利

任何人均享有身体与人格安全、法律地位、必要照护、时间与空间、信息与记录权、随能力发展的发声和决定、支持性决策、真实退出、服务连续及低成本救济。年龄、残障、诊断、家庭身份和表达方式不得成为暂停人格地位的理由。

第四条 照护双重权利

被照护者有权获得连续、尊重意愿和文化差异的支持；照护者有权休息、健康保护、收入连续、培训、社会参与和拒绝无限义务。公共系统须提供喘息、替代和危机接替，不得把未提供服务自动记为家庭自愿承担。双方发生重大利益冲突时，由独立于双方及服务提供者的第三方按最小限制原则作出限时决定并记录异议。

第五条 真实退出

退出权包括安全、住所、身份文件、基本收入或服务、教育医疗连续、通信、记录可携和免受报复。对不可退出或退出即伤害的关系，应以独立声音、支持性决策、替代照护和高门槛复核补充，而不得只提供形式离开权。

第六条 儿童与演进中的自主

儿童在一切影响其利益的程序中享有适龄信息、表达、回应和独立支持。决定权应随能力、事项风险和可逆性递进。重大利益冲突、明确异议和不可逆处置须指定独立儿童代理，并接受及时外部复核。

第七条 能力推定与支持性决策

任何人应被推定能够参与特定决定。机构须先提供信息、沟通、无障碍、时间和可信支持，再讨论替代决定。能力认定限于具体事项和期限，定期复审，不得一次认定、终身失权。

第八条 分类、记录与数据

高影响分类须区分事实、推断和异议，公开目的、来源、适用范围、置信度、期限、访问和复核。记录主体有权知悉、查阅、更正、附加陈述、限制用途并在目的消失后要求删除。更正、删除和限制使用应通知全部已知下游接收者，覆盖副本、缓存和派生个人画像；下游须限期停用并回执，迟延继续使用构成独立侵害。自动系统不得单独作出重大强制和不可逆决定。

第九条 生活机构内部宪制

学校、医院、照护机构、宗教组织、社团、公共媒体、大型平台和使用公共资源的社区组织，应具有公开规则、责任人、利益回避、信息权、申诉、少数报告、外部复核和反报复机制。家庭涉及重大财产、身体、教育、监护和长期记录的决定，亦适用相应权利底线。

第十条 轻触双回路

第一回路优先提供信息、支持、适配、喘息服务、协商和关系修复；第二回路在暴力、迫近严重伤害、无真实退出、无独立声音、高影响决定无复核或申诉报复时启动。共同生活救济中心的权限限于入口、分流、七十二小时以内的临时措施和执行督办，不得签发第四级措施、经营安置服务、分配长期照护预算或主持同案最终复审，也不得主动生成风险名单和持有跨案原始生活数据库。中心自身的临时措施和代理指派须可即时申诉；高影响措施自动接受中心之外的快速复核，超期未复核原则上自动解除。

第十一条 最小介入与不可逆处置

外部措施应从支持、适配、临时保护到重大强制逐级提高证据和授权门槛。不可逆或重大限制措施须证明较轻替代不足，取得独立授权，设定最短期限、自动复审、法律帮助、退出条件和错误赔偿。儿童带离、强制医疗和其他第四级措施超过七十二小时，须由未参与调查、安置、治疗和服务提供的独立裁决者续期；每次续期有固定上限。决定书须写明决定者、复审者、执行者、时限、逾期后果和先行赔偿责任人。

第十二条 规训盈余与对称问责

“规训盈余”是一个审计性工作概念，以相对于预先登记的最小充分方案多出的数据字段、共享对象、限制强度、覆盖人数和持续期限近似衡量；它不能被单一数值直接测出，结论须同时标明证据和不确定性。依法应介入而不作为，以及依据不足、措施过重、超期不退出和记录不更正，均应受到审查和救济。过度介入由实施机构预列账户先行赔偿，公共过错救济基金在其不足时预付并依法追偿。救济决定须写明触发条件、付款账户、到账期限和拒付后的执行途径。机构考核不得只奖励发现风险和采取强制。

第十三条 宗教、社团和社区自治

宗教、社团和社区享有内容与组织自治，但不得实施暴力、扣押证件财产、阻断教育医疗与外部信息、强迫婚育或惩罚退出。内部少数和退出者有权不经内部权威许可直接获得外部救济。

第十四条 医疗、监护与强制

知情同意应与事项风险相匹配。急迫危险中的必要措施只持续最短时间。强制医疗、长期监护、儿童带离和其他重大限制须由独立于服务提供者的主体授权并自动复审；专业判断不得成为不受挑战的永久替代决定。

第十五条 真实匮乏与未履行义务

照护、住房、医疗和支持能力不足时，应公开需求、能力、等待、未满足服务、优先规则、追加责任和过渡支持。未履行不得改名为已经保障，也不得默认为家庭、儿童或照护者自愿承担。

第十六条 试点、比较与回滚

独立代理、救济中心、照护账户、分类日落和平台复核等机制，应以有边界、有替代、有分群指标、有长期随访和停止条件的方式试点。扩围须比较误报漏报、严重伤害、关系修复、服务缺口、财政与组织成本。越过基本权利、过度介入或数据滥用红线者应暂停、修订或退出。

第十七条 合法执行依赖

本编规定的保护、复审、更正、赔偿和退出依赖合法强制机关以及学校、医院、平台、社团和监护人按时执行。每项决定须列明执行主体、完成时限、拒绝执行的即时报告途径和逾期责任；逾期不履行构成独立可诉事项，法院可以签发执行令、按日罚款或暂停相关公共资金，但不得因制裁中断当事人的基本服务。强制机关系统性拒绝、扩大执行或以安全保密阻断救济的，应移交《法治与强制权》，并重新审查本编的有效性。

第十八条 救济机构内部宪政

共同生活救济中心、独立儿童代理和独立临床复核机构须与调查、服务提供、安置和强制机关分离。临时保护与程序复审实行不同人员、预算线和责任人；同一人员不得参与同案两项职能。代理人一案一任、轮转指派并披露利益冲突。救济机构不得持有跨案原始生活总库，其自身错误和规训盈余同样适用第十二条。救济中心自身的高影响措施由中心之外的法定独立裁决者快速复核，中心不得自行续期。

第十九条 理论的可修订性

若本理论的概念、分类或机构持续遗漏受损者、制造不可纠正的支配、扩大规训盈余或被更好的制度替代，应公开修订或退出。批评、反证和替代生活形式不得被视为对家庭、共同体或社会的不忠。

附录二 青禾家庭事实表与决策节点

一 事实边界

青禾家庭、人物、时间、金额和机构均为虚构。案例只用于检验时间、现金、服务、信息、决定权和损失能否被同时追踪，不证明任何现实地区的家庭风险、财政能力或最优阈值。

二 六张流向表

时间表记录林芸、林和、外祖母、专业人员和公共服务的工作、照护、等待、休息和程序时间。现金表记录家庭收入、基线支出、减工损失、公共服务、补贴、安置、法律和修复费用。服务表记录承诺、实际提供、等待、未满足和替代服务。

信息表区分原始事实、当事人陈述、专业意见、算法推断、匿名报告、访问者、更正和删除期限。权限表列明普通决定、高影响决定、临时保护、重大强制、复审、执行和赔偿分别由谁负责。损失表记录身体、心理、关系、学业、收入、声誉、隐私与窗外长期损失，不能只合并成货币总额。

六表至少满足三组可核对关系。照护总需求＝家庭成员自愿且可持续承担＋公共实供＋临时替代＋未履行；家庭净现金损失＝减工＋交通＋咨询及其他必要支出－补贴－赔偿；错误标签处置＝已知下游接收者＋更正通知送达＋停用或删除回执＋依法保留且限期复审。任何一项不能对平，都须说明缺失由谁暂时承担，不得记为零。

青禾示范账的基准值为：照护总需求一百三十六小时＝林芸九十＋林和三十＋社区十六＋未履行零。正常修正月份为：一百三十六小时＝林芸六十六＋社区原有十六＋新增常规实供三十＋喘息实供二十四＋林和固定照护零＋未履行零；十小时弹性容量单列，不在未调用时计入实供。调用x小时时，必须等量替代某项原定劳动，不能增加需求总量。实际月份须用实供而非承诺小时重算，常规缺口与备用能力缺口分别记录。公共现金账应把安置、评估、上门、喘息、备用容量、教育适配、法律援助、补贴、赔偿和关系修复分列。

三 基准决策链

第一步核实是否存在具体迫近危险。第二步为儿童与家庭分别配置可信沟通和独立支持。第三步核对照护、住房、收入、学校适配和医疗服务是否缺失。第四步比较能够防止伤害的最轻措施。第五步对重大限制取得独立授权并规定自动复审。第六步记录全部流向和异议。第七步在事实改变或期限届满时退出、修正和赔偿。

青禾案的带离记录须固定为四列。机构拟定期限：二十一日，仅为申请意见。法定授权期限：第零日二十一时五十分至第三日二十一时五十分，共七十二小时，由中心之外的法定独立裁决者签发。实际持续期限：至第七日二十一时五十分，共七日。超期部分：第三日到期后至第七日共九十六小时，无新证据、无续期命令，属于安置机构未按时解除而非“默示续期”。提出者、授权者、照护提供者、复审者和赔偿责任人不得合并为同一主体。

四 不可逆处置的失败节点

若低置信度标签直接触发第四级措施，若决定机构同时控制定义、安置和复审，若没有证明支持性替代不可用，若儿童无独立声音，若过度介入损失不进入责任账户，则制度失败。即使事后没有发生更严重伤害，也不能用结果为错误程序追认正当性。

五 跨章索引

照护时间与服务缺口对应第三章，儿童声音、学校标签和档案对应第四章，评估与支持性决策对应第五章，平台数据与社区权威对应第六章，分级介入和救济对应第七章，分群评价和试点比较对应第八章，完整失败处置对应第九章。

六 同口径反事实表

案例结案须比较至少三案：无专项介入、广泛预警与带离、支持优先且分级介入。三案使用同一三十日窗口、家庭事实、服务能力、工资和价格，分别报告六张流向表；一年后追加严重伤害、再介入、关系、学业、健康和声誉。另以同校相似课堂行为但无照护负担者作差异参照。正文暂未填入真实单价和长期结果，因此只能提供表结构，不能宣布第三案成本更低或效果更优。

附录三 设计参数、证据边界与未决问题

一、二十一日申请期限、七十二小时合法授权、七日实际留置、每月三十小时常规上门服务、十小时备用容量、二十四小时喘息服务、六个月过渡补贴及一千二百元金额，均为案例参数，不是已证明最优的标准。现实规则须按风险、服务能力、误报漏报、关系修复和分群结果校准。申请、授权、实供、容量和实际持续时间不得因采用同一计量单位而合并。

二、必须作为规范底线的命题包括反暴力与反强迫、平等人格、外部求助、支持先于替代、不可逆措施最高门槛、真实退出、基本服务连续和错误救济。这些底线不由满意度和总收益投票取消。

三、必须以经验资料检验的事项包括无偿照护时间、照护缺口、学校处分与分流、分类误差、跨域数据访问、强制医疗、监护与儿童带离、申诉成本、决定推翻率、服务等待、关系修复和长期能力结果。平均值必须与性别、年龄、收入、残障、家庭结构、地区和身份分群结果并列。分群统计只能用于发现制度差异，不得生成个体风险名单；采用足以降低再识别风险的最小发布粒度，去识别密钥由独立数据受托人保管。

四、只能通过比较试点回答的问题包括：共同生活救济中心的组织形式，独立代理触发阈值，儿童能力与事项矩阵，支持性决策的具体工具，档案日落期限，匿名举报的核验规则，平台风险提示的误差边界，过度介入赔偿及照护账户的财政和行为影响。支持性决策优先与最佳利益替代决定之间存在真实规范冲突，尤其是在急性精神危机、严重认知障碍和儿童高风险情形；本文规定顺序和最低程序，不宣称已经消除分歧。

青禾案例还假定法定独立值班裁决者、分离的短期照护提供者和外部通信在夜间真实可用；若这些能力只存在于工作日或中心城区，案例的授权链就不能运转。试点须分别报告夜间、周末、偏远地区和无可信成年人情形的响应时间、实际空缺与强制升级率，不能把纸面名册当作可用能力。

五、仍须研究组织激励。学校、医院、社工、平台和救济机构会因免责、预算、工作量、声誉和指标采取防御行为。只增加“必须保护”的义务可能使过度介入上

升；只惩罚过度介入又可能增加漏报。对称问责能否改变这种结构，需要真实案件、工作人员时间和反事实比较。

六、隐私与协调不存在一次性最优解。集中数据库、联邦式查询、个人数据钱包和经授权案例会议各有风险；应比较数据泄露、重复举证、纠错速度、服务连续和权力集中，而不能由技术方便决定。

七、本文可以声称的是：退出失灵条件下的日常支配已经被写成一套具有权利、权限、介入阶梯、救济和失败标准的共同生活宪制；“退出三类”和“规训盈余”是组织既有争论的工作性综合，不以名称证明原创性。本文不能声称的是：具体参数已经校准，外部救济必然优于自治，支持性决策在所有情形都可行，或本方案已经在现实中证明优于替代制度。

附录四 文献对话索引

以下索引说明本稿与哪些问题对话，不表示相关作者赞成本稿，也不以姓名替代制度论证。版本与译名在正式引证时仍须逐项校核。

一、社会再生产、家庭与照护。Karl Marx《资本论》第一卷及其关于劳动力再生产的论述，为生产体系依赖生活维持提供起点；Lise Vogel《马克思主义与妇女受压迫》、Silvia Federici《反对家务劳动》、Nancy Fraser关于资本主义照护矛盾的论述，用于无偿劳动和制度性转嫁。本文继承其物质分析，同时拒绝把亲密、身份和专业权力全部还原为工资关系。Joan Tronto《道德边界》和Eva Feder Kittay《爱的劳动》用于照护依赖、责任和照护者地位；本文拒绝把照护浪漫化为天然无私领域。

二、正义、能力与家庭内部权力。John Rawls《正义论》与《政治自由主义》用于平等基本地位和公共理由；Susan Moller Okin《正义、性别与家庭》用于家庭结构对机会与公民地位的影响；Amartya Sen《以自由看待发展》和Martha Nussbaum的能力进路用于从资源转向真实能力。本文使用能力作为评价尺度，但不把完整能力清单变成统一生活模板。

三、行动、生活世界与公共出现。本文发展Hannah Arendt《人的境况》中关于显现、复数性和共同世界的论述，使其进入照护依赖、分类与代理决定；同时在其对社会再生产内部政治可见性讨论不足之处作出补充，而不把劳动、制作与行动的概念区分简单解释为价值高低。Jürgen Habermas《交往行为理论》用于生活世界受行政和货币系统侵蚀的诊断；本文不赋予理想言语情境以决定性地位，也不假定充分沟通必然形成共识，而以权利红线、多元共存和可退出处理持续冲突。

四、规训、机构与污名。Michel Foucault《规训与惩罚》及相关生命政治讲座用于分类、档案、专业目光和保护性权力；Erving Goffman《精神病院》和《污名》用于全控机构、身份损伤和日常互动。本文继承其警觉，却不止于无出口的诊断，而尝试用独立复审、档案日落和对称问责形成规范回应。“规训盈余”只是把这种警觉与比例原则、最小限制替代结合起来的工作概念，不主张是一个脱离既有传统的全新理论范畴。

五、儿童、照护垄断、残障与支持性决策。《儿童权利公约》用于儿童利益、表达与成长中的自主，《残疾人权利公约》用于法律人格、无障碍、社区生活和支

持性决策。Anca Gheaus在“ Children ’ s Vulnerability and Legitimate Authority OverChildren ”， Journal of Applied Philosophy 35(S1), 2018, pp. 60 – 75中，从儿童的一般脆弱性推出免受照护垄断的权利，主张照护与权威由利益并非完全捆绑的多个来源分担。其方案的优势在于事前改变关系结构，使儿童不必等到伤害发生后才接触家庭外成年人；相较之下，本文的支持网络、独立代理和触发式救济增加了适用于学校、医院、平台、监护与照护关系的权限链、记录纠错和错误赔偿，但可能介入过晚，也可能形成新的专业垄断。

两种进路不应被写成简单替代。稳定的非父母照护关系可以分散定义权和求助入口，却也可能造成责任碎片化、照护者冲突、关系不稳定，并因阶层与地区差异而分配不均；触发式公共救济能够处理明确冲突和跨机构错误，却不能代替儿童在日常生活中拥有多个可信、持续的关系。本文因此把“ 多源稳定照护 ”列为第一回路的优先条件，把独立代理和外部复审保留为第二回路，而不声称任何单一代理模型已经经验最优。

六、多中心共同体与制度变迁。Elinor Ostrom《公共事物的治理之道》用于边界、规则修改、在地监测、低成本争端和多中心复核；Douglass C. North《制度、制度变迁与经济绩效》用于可信承诺、非正式规则和路径依赖；Max Weber《经济与社会》用于合法支配、科层和专业权威。本文继承多中心治理，却拒绝把家庭、熟人和社区自治浪漫化。

七、隐私、数据与平台权力。Helen Nissenbaum《情境中的隐私》用于信息流的情境完整性，Shoshana Zuboff《监视资本主义时代》用于行为数据和预测权力的批判。本文不把所有数据使用等同于监视，而要求目的限制、最小必要、访问日志、纠错、期限和高影响决定的人类责任。

八、文化、宗教与内部少数。Iris Marion Young《正义与差异政治》用于差异、结构压迫和群体代表，Ayelet Shachar《多元文化管辖》用于文化群体自治与内部成员权利的冲突。本文保护共同体差异，同时坚持暴力、强迫、外部求助和真实退出的最低边界。

九、文献不能完成的工作。上述理论能够揭示依赖、分类、照护和规训问题，却不能替代照护时间表、服务等候、分类误差、申诉记录、儿童与患者长期结果、

数据访问日志和真实预算。经验与理论冲突时，应检查概念和制度，而不能增加引文来排除反例。